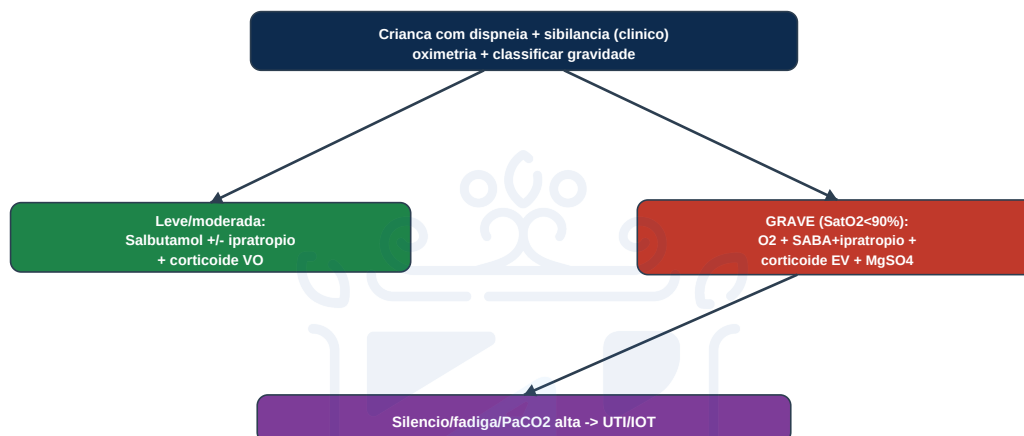


ASMA NA CRIANÇA — SABA + CORTICOIDE

FLUXOGRAMA — CLASSIFICAR E TRATAR

CRISE DE ASMA — GRAVIDADE GUIA A CONDUTA



DIAGNÓSTICO

EMINENTEMENTE CLÍNICO

- Dispneia, sibilância, tosse e aperto no peito, com ausculta de broncoespasmo bilateral
- Anamnese-chave: tempo de início, gatilho (IVAS/alérgeno/poluentes/estresse), uso atual de medicação
- FATOR DE RISCO PARA ASMA QUASE FATAL: internação/IOT/ventilação prévias por asma
- Buscar complicadores: febre, pneumonia, atelectasia, hemoptise
- Diferenciais: aspiração de corpo estranho, obstrução laríngea, insuficiência cardíaca

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE

Parâmetro	Leve	Moderada	Grave
Fala	Frases completas	Frases curtas/palavras	Palavras isoladas
SatO2 (ar ambiente)	> 95%	90-95%	< 90%
Sibilos	Leves	Audíveis	Musc. acessória / silêncio
Estado	Tranquilo	Agitação leve	Confusão/sonolência (hipercapnia)

RED FLAGS — ASMA GRAVE / IMINÊNCIA DE PARADA

SINAIS DE ALARME

- Incapacidade de falar frases; uso de musculatura acessória; cianose central
- SILÊNCIO respiratório (tórax silencioso = obstrução severa do fluxo)
- Alteração neurológica: confusão, agitação, sonolência (sugere hipercapnia)
- PaCO2 > 45 mmHg ou em elevação; SatO2 < 90% apesar do tratamento
- Pulso paradoxal > 20 mmHg, bradicardia; FADIGA/exaustão respiratória

TRATAMENTO — LEVE/MODERADA

Rx SABA + CORTICOIDE

Salbutamol aerossol (100 mcg/jato) com ESPAÇADOR: 4-10 jatos a cada 20 min, 3 vezes (depois conforme necessidade)
Brometo de ipratrópio (20 mcg/jato): < 2 anos 4 jatos / > 12 anos 8 jatos, a cada 20 min, 3 vezes
Corticoide sistêmico: Prednisolona/Prednisona VO 1-2 mg/kg/dia por 3-5 dias
Dexametasona 0,6 mg/kg VO (máx 10 mg) dose única — opção se vômitos
Oximetria seriada; sempre usar espaçador (com máscara facial em lactentes)

TRATAMENTO — GRAVE

Rx O2 + SABA + IPATRÓPIO + CORTICOIDE EV + MgSO4

Oxigenoterapia para manter SatO2 adequada (alvo $\geq 94\%$)
Salbutamol + ipratrópio nas doses acima (nebulização/aerossol contínuos conforme resposta)
Corticoide EV: Metilprednisolona EV OU Dexametasona 0,6 mg/kg EV (máx 10 mg)
Sulfato de magnésio 50 mg/kg EV em 20 min (máx 2 g)
Salbutamol EV (refratário): ataque 10 mcg/kg + manutenção 0,1-1 mcg/kg/min
Sem resposta / fadiga / PaCO2 em elevação -> VNI ou IOT + UTI

QUANDO PEDIR EXAMES

POUCOS, SELETIVOS

- Oximetria de pulso: SEMPRE (seriada — gravidade e resposta)
- Laboratório: NÃO de rotina; não deve atrasar o tratamento
- RX de tórax: só se ausência de resposta ou suspeita de complicação (pneumonia, pneumotórax, atelectasia, corpo estranho)
- Gasometria: considerar em crise grave sem resposta/deterioração — PaCO2 normal ou alta (> 45) indica insuficiência respiratória iminente
- Atenção: na crise grave, uma PaCO2 'normalizada' pode ser sinal de exaustão (alarme)

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR/UTI: insuficiência respiratória mantida, SatO2 $< 90\%$ apesar do tratamento, alteração de consciência, PaCO2 > 45 /elevação, necessidade de VNI/IOT, instabilidade, complicações, sem condição de seguimento
- ☐ ALTA: boa resposta, SatO2 $> 94\%$ em ar ambiente, sem desconforto, falando frases completas, sem musculatura acessória, tolerando corticoide VO, família orientada
- ☐ Receita: Salbutamol com espaçador + Prednisolona 1-2 mg/kg/dia por 3-5 dias (manhã)
- ☐ Demonstrar técnica do espaçador; orientar gatilhos e sinais de alerta
- ☐ RETORNO ambulatorial em 48h (24-48h em lactentes); retorno imediato se piora

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos/____ kg com crise asmática há ____; gatilho ____; IOT/internação prévia: ____.
- SatO2 ____, fala ____, musculatura acessória ____, nível de consciência ____; PaCO2 ____.
- Tratado: O2 ____, salbutamol + ipratrópio ____ ciclos, corticoide ____, MgSO4 ____, salbutamol EV ____; resposta ____.
- Solicito UTI pediátrica + suporte ventilatório (VNI/IOT); manter broncodilatador no transporte.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança com crise asmática grave, SatO₂ 88%, uso de musculatura acessória, sem resposta após broncodilatador inicial. Além de O₂, salbutamol e ipratrópio, qual a conduta?

- A) Antibiótico de rotina
- B) Corticoide endovenoso + sulfato de magnésio 50 mg/kg EV (máx 2 g)
- C) Anti-histamínico
- D) Apenas observação
- E) Adrenalina nebulizada isolada

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual medicação é fundamental e deve ser administrada precocemente em toda crise asmática moderada/grave?

- A) Antibiótico
- B) Corticoide sistêmico (prednisolona VO ou metilprednisolona/dexametasona EV)
- C) Anti-histamínico
- D) Mucolítico
- E) Antitussígeno

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado indica obstrução grave do fluxo aéreo (sinal de alarme) na crise asmática?

- A) Sibilos abundantes e altos
- B) Tórax silencioso (ausência de sibilos por redução severa do fluxo)
- C) Tosse seca isolada
- D) Febre baixa
- E) Coriza

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a radiografia de tórax na crise asmática pediátrica, é correto:

- A) Deve ser feita em todos os casos
- B) Não é de rotina; indicar só se ausência de resposta ao tratamento ou suspeita de complicação
- C) Substitui a oximetria
- D) É obrigatória antes do broncodilatador
- E) Deve atrasar o início do tratamento

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o critério adequado de alta após crise asmática na criança?

- A) SatO₂ 85% em ar ambiente
- B) SatO₂ > 94% em ar ambiente, sem desconforto, falando frases completas e tolerando corticoide oral
- C) Persistência de tiragem leve
- D) Necessidade de O₂ suplementar
- E) Uso de musculatura acessória ainda presente

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na crise grave sem resposta às medidas iniciais, acrescentam-se corticoide EV e sulfato de magnésio 50 mg/kg EV em 20 min (máx 2 g); persistindo, considera-se salbutamol EV e suporte ventilatório (VNI/IOT) em UTI.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O corticoide sistêmico (prednisolona VO; metilprednisolona ou dexametasona EV nas graves) é fundamental e deve ser administrado precocemente, pois reduz a inflamação e as recidivas. Antibiótico não é de rotina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O tórax silencioso (ausência de sibilos) indica fluxo aéreo gravemente reduzido — sinal de alarme de obstrução severa e iminência de insuficiência respiratória, não de melhora.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A radiografia de tórax não é de rotina; indica-se apenas na ausência de resposta ao tratamento ou suspeita de complicação (pneumonia, pneumotórax, atelectasia, corpo estranho), sem atrasar a terapia.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A alta é segura com SatO₂ > 94% em ar ambiente, respiração confortável sem musculatura acessória, fala em frases completas e tolerância ao corticoide oral, com família orientada e retorno em 48h.

SM24
Suporte ao Plantão Médico